

CAS CLINIQUES DE PATHOLOGIE NEUROLOGIQUE CENTRALE

Yasser Mecheri

CAS CLINIQUE 01

- Patiente de 32 ans, aucun antécédent personnel ou familial..
- Depuis 2 jours, elle présente une gêne visuelle de l'œil droit. Vison d'une tache noire au centre de celui-ci. De plus, l'œil est douloureux lorsqu'elle le mobilise.
- À l'examen, l'œil n'est pas rouge.
- Lorsque vous éclairez l'œil droit, les pupilles des deux yeux restent en position intermédiaire, alors que lorsque vous éclairez l'œil gauche, les deux pupilles se mettent en myosis. Vous notez également au passage de l'éclairage de la pupille gauche à la pupille droite une dilatation paradoxale de cette dernière.
- Le reste de l'examen clinique est normal.

Question 1

- Quel(s) signe(s) clinique(s) présente la patiente à l'évaluation du réflexe photomoteur?

A signe de Lhermitte

B signe de Marcus-Gunn

C signe d'Uhthoff

D signe d'Argyll-Robertson

E signe d'Hoffman

Question 1

- Quel(s) signe(s) clinique(s) présente la patiente à l'évaluation du réflexe photomoteur?

A signe de Lhermitte

B signe de Marcus-Gunn

C signe d'Uhthoff

D signe d'Argyll-Robertson

E signe d'Hoffman

Question 2

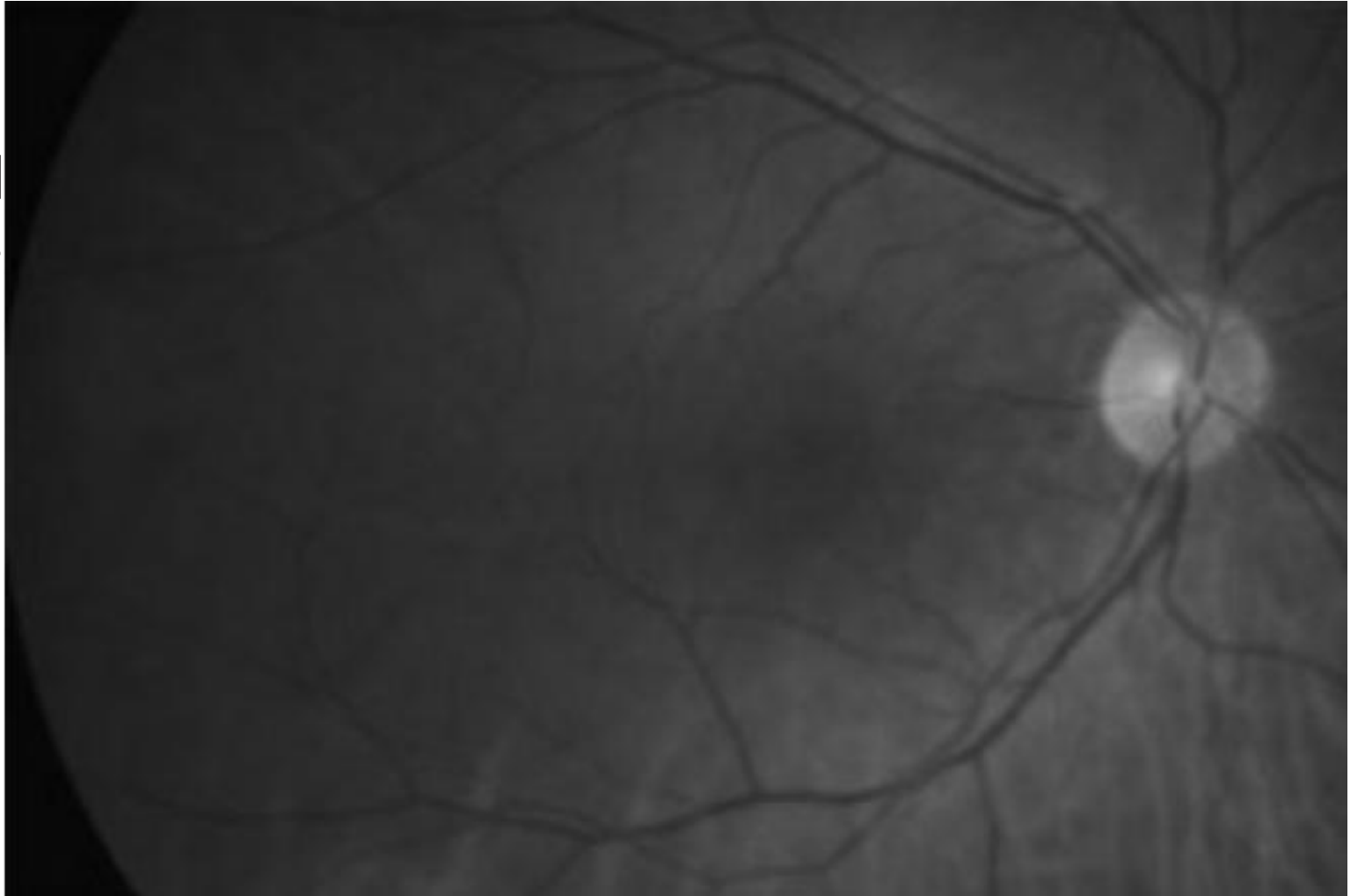
- Vous réalisez un fond d'œil. L'œil droit est présenté ci-dessous ([figure 30.6](#)). Quelle(s) est (sont) votre (vos) conclusion(s)?

- A** œdème papillaire
- B** atrophie papillaire
- C** macula rouge cerise
- D** hémorragies en flammèches
- E** normal

Question 2

- Vous réalisez un fond d'œil (figure 30.6). Quelle(s) est (sont) la (les) pathologie(s) observée(s) ?

- A** œdème papillaire
- B** atrophie papillaire
- C** macula rouge cerise
- D** hémorragies en flamme
- E** normal



Question 2

- Vous réalisez un fond d'œil. L'œil droit est présenté ci-dessous ([figure 30.6](#)). Quelle(s) est (sont) votre (vos) conclusion(s)?

A œdème papillaire

B atrophie papillaire

C macula rouge cerise

D hémorragies en flammèches

E normal

Question 3

- Le compte rendu de l'ophtalmologue conclut à la normalité du fond d'œil. Quel(s) diagnostic(s) évoquez-vous?
- A** neuropathie optique ischémique antérieure aiguë droite
- B** occlusion de l'artère centrale de la rétine
- C** poussée de sclérose en plaques
- D** névrite optique rétrobulbaire droite
- E** occlusion de la veine centrale de la rétine

Question 3

- Le compte rendu de l'ophtalmologue conclut à la normalité du fond d'œil. Quel(s) diagnostic(s) évoquez-vous?
- A** neuropathie optique ischémique antérieure aiguë droite
- B** occlusion de l'artère centrale de la rétine
- C** poussée de sclérose en plaques
- D** **névrite optique rétrobulbaire droite**
- E** occlusion de la veine centrale de la rétine

Question 4

- Vous suspectez une névrite optique rétrobulbaire droite. Parmi les examens ophtalmologiques suivants, lequel (lesquels) peu(ven)t être anormal (aux) dans le cadre de cette affection?

- A** test de vision des couleurs
- B** examen à la lampe à fente
- C** Mesure de pression oculaire
- D** pachymétrie
- E** gonioscopie

Question 4

- Vous suspectez une névrite optique rétrobulbaire droite. Parmi les examens ophtalmologiques suivants, lequel (lesquels) peu(ven)t être anormal (aux) dans le cadre de cette affection?

A test de vision des couleurs

B examen à la lampe à fente

C Mesure de pression oculaire

D pachymétrie

E gonioscopie

Question 5

- Quelle prise en charge thérapeutique de cette névrite optique rétrobulbaire proposez-vous?
- A** méthylprednisolone par voie intraveineuse
- B** prednisolone par voie orale
- C** interféron bêta
- D** acétate de glatiramère
- E** anti-inflammatoire non stéroïdien

Question 5

- Quelle prise en charge thérapeutique de cette névrite optique rétrobulbaire proposez-vous?

A méthylprednisolone par voie intraveineuse

B prednisolone par voie orale

C interféron bêta

D acétate de glatiramère

E anti-inflammatoire non stéroïdien

Question 6

- Vous suspectez le diagnostic de sclérose en plaques. Quel(s) examen(s) systématique(s) de première intention réalisez-vous dans l'immédiat?

A ponction lombaire

B IRM médullaire

C potentiels évoqués visuels

D potentiels évoqués somesthésiques

E IRM cérébrale

Question 6

- Vous suspectez le diagnostic de sclérose en plaques. Quel(s) examen(s) systématique(s) de première intention réalisez-vous dans l'immédiat?

A ponction lombaire

B IRM médullaire

C potentiels évoqués visuels

D potentiels évoqués somesthésiques

E IRM cérébrale

Question 7

- Vous avez réalisé une ponction lombaire au cours du séjour de la patiente. Parmi les résultats suivants, lequel (lesquels) est (sont) compatible(s) avec le diagnostic de sclérose en plaques?
- A** globules rouges : 5/mm₃, leucocytes : 2/mm₃, protéines : 0,75 g/l
- B** globules rouges : 3/mm₃, leucocytes : 15/mm₃, protéines : 0,50 g/l
- C** globules rouges : 1/mm₃, leucocytes : 120/mm₃, protéines : 0,90 g/l
- D** globules rouges : 2/mm₃, leucocytes : 3/mm₃, protéines : 2,80 g/l
- E** globules rouges : 1/mm₃, leucocytes : 12/mm₃, protéines : 0,80 g/l

Question 7

- Vous avez réalisé une ponction lombaire au cours du séjour de la patiente. Parmi les résultats suivants, lequel (lesquels) est (sont) compatible(s) avec le diagnostic de sclérose en plaques?

- A globules rouges : 5/mm₃, leucocytes : 2/mm₃, protéines : 0,75 g/l**
- B globules rouges : 3/mm₃, leucocytes : 15/mm₃, protéines : 0,50 g/l**
- C globules rouges : 1/mm₃, leucocytes : 120/mm₃, protéines : 0,90 g/l**
- D globules rouges : 2/mm₃, leucocytes : 3/mm₃, protéines : 2,80 g/l**
- E globules rouges : 1/mm₃, leucocytes : 12/mm₃, protéines : 0,80 g/l**

Question 8

- Finalement vous n'avez pas débuté de traitement de fond. La patiente vous l'a perdu de vue.
- Malheureusement, elle revient vous consulter 3 ans plus tard car depuis 48 heures, au lever, elle a senti une difficulté à l'appui de la jambe droite, elle ressent quelques picotements sur son membre inférieur gauche. L'étude de la marche montre effectivement un membre inférieur droit traînant et semblant retomber lourdement sur le sol. Au niveau de la force musculaire segmentaire, celle-ci est cotée à 5/5 aux membres supérieurs ainsi qu'au membre inférieur gauche, par contre, elle est à 4/5 au membre inférieur droit aussi bien en proximal qu'en distal. Les réflexes tendineux sont discrètement plus vifs au MID. Le réflexe cutané plantaire est en extension du côté droit.

- La patiente perçoit difficilement le diapason au membre inférieur droit jusqu'au niveau de l'épine iliaque antérosupérieure. Le sens de position du gros orteil droit est également mal défini par la patiente.
- Au niveau du membre inférieur gauche, on note une diminution de la sensibilité au chaud et au froid ainsi qu'à la douleur remontant jusqu'au niveau de l'ombilic. Le reste de l'examen est normal hormis un signe de Marcus-Gunn à droite. Quel est votre diagnostic syndromique?

- A** syndrome de Brown-Séquard gauche de niveau T10
- B** syndrome de Brown-Séquard droit de niveau T6
- C** syndrome de Brown-Séquard gauche de niveau T4
- D** syndrome de Brown-Séquard droit de niveau T10
- E** syndrome de Brown-Séquard gauche de niveau T6

- La patiente perçoit difficilement le diapason au membre inférieur droit jusqu'au niveau de l'épine iliaque antérosupérieure. Le sens de position du gros orteil droit est également mal défini par la patiente.
- Au niveau du membre inférieur gauche, on note une diminution de la sensibilité au chaud et au froid ainsi qu'à la douleur remontant jusqu'au niveau de l'ombilic. Le reste de l'examen est normal hormis un signe de Marcus-Gunn à droite. Quel est votre diagnostic syndromique?

A syndrome de Brown-Séquard gauche de niveau T10

B syndrome de Brown-Séquard droit de niveau T6

C syndrome de Brown-Séquard gauche de niveau T4

D syndrome de Brown-Séquard droit de niveau T10

E syndrome de Brown-Séquard gauche de niveau T6

Question 10

- La patiente va mieux avec votre traitement par baclofène.
- Quatre ans après, elle vous consulte pour un nouveau phénomène. En effet, elle présente des douleurs localisées au niveau de la pommette gauche, de l'aile du nez gauche et de la paupière inférieure gauche. Elle se plaint aussi de la gencive supérieure gauche. Ses douleurs surviennent en éclair, sont très vives comme une décharge électrique et durent quelques secondes. Elles sont tellement intenses qu'elles obligent l'arrêt de toutes les activités en cours. Elles peuvent se répéter plusieurs fois par jour, depuis plusieurs mois maintenant. Vous suspectez quoi?

Question 11

- Vous suspectez une névralgie du trijumeau. Parmi les éléments suivants, lequel (lesquels) serai(en) t évocateur(s) d'une névralgie secondaire (symptomatique) du trijumeau?

- A** atteinte d'une des trois branches du nerf
- B** hypoesthésie du territoire du trijumeau homolatérale à la douleur
- C** faiblesse du muscle masséter homolatérale à la douleur
- D** fond douloureux permanent
- E** abolition du réflexe cornéen homolatérale à la douleur

Question 11

- Vous suspectez une névralgie du trijumeau. Parmi les éléments suivants, lequel (lesquels) serai(en) t évocateur(s) d'une névralgie secondaire (symptomatique) du trijumeau?

- A atteinte d'une des trois branches du nerf**
- B hypoesthésie du territoire du trijumeau homolatérale à la douleur**
- C faiblesse du muscle masséter homolatérale à la douleur**
- D fond douloureux permanent**
- E abolition du réflexe cornéen homolatérale à la douleur**

Question 12

• Quel(s) traitement(s) de première intention proposez-vous?

A lamotrigine

B carbamazépine

C oxcarbazépine

D vérapamil

E gabapentine

Question 12

• Quel(s) traitement(s) de première intention proposez-vous?

A lamotrigine

B carbamazépine

C oxcarbazépine

D vérapamil

E gabapentine

Question 13

- Vous choisissez un traitement par carbamazépine (Tégrétol). Quelle surveillance biologique préconisez-vous?

- A** thyroid-stimulating hormone (TSH)
- B** calcémie
- C** numération-formule sanguine (NFS)
- D** transaminases
- E** natrémie

Question 13

- Vous choisissez un traitement par carbamazépine (Tégréto). Quelle surveillance biologique préconisez-vous?

A thyroid-stimulating hormone (TSH)

B calcémie

C numération-formule sanguine (NFS)

D transaminases

E natrémie

Question 14

- Ravie de votre prise en charge, votre patiente vous adresse sa cousine âgée de 25 ans qui présente une maladie migraineuse depuis l'adolescence. Elle a pour autres antécédents un asthme et une dépression. Elle vous dit avoir des auras visuelles avant certaines de ses crises. Parmi les caractéristiques sémiologiques suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) typique(s) d'une aura migraineuse visuelle?
- A** installation des troubles en moins de 5 minutes
 - B** topographie hémianopsique latérale homonyme
 - C** durée maximale de 3 heures
 - D** scotome scintillant
 - E** régression après la résolution de la céphalée

Question 14

- Ravie de votre prise en charge, votre patiente vous adresse sa cousine âgée de 25 ans qui présente une maladie migraineuse depuis l'adolescence. Elle a pour autres antécédents un asthme et une dépression. Elle vous dit avoir des auras visuelles avant certaines de ses crises. Parmi les caractéristiques sémiologiques suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) typique(s) d'une aura migraineuse visuelle?
- A** installation des troubles en moins de 5 minutes
 - B** topographie hémianopsique latérale homonyme
 - C** durée maximale de 3 heures
 - D** scotome scintillant
 - E** régression après la résolution de la céphalée

Critères diagnostiques de la migraine sans aura selon l'International Headache Society (version ICHD-3)^[3].

A. Au moins cinq crises répondant aux critères B à D

B. Crises céphalalgiques durant 4 à 72 heures (non traitées ou traitées inefficacement)

C. Céphalée ayant au moins deux des caractéristiques suivantes :

1. topographie unilatérale
2. tonalité pulsatile
3. intensité douloureuse modérée ou sévère
4. aggravation par l'activité physique de routine ou limitation de cette dernière (par exemple, marche ou montée des escaliers)

D. Durant la céphalée au moins un des symptômes suivants :

1. nausées et/ou vomissements
2. photophobie et phonophobie

E. N'est pas mieux expliqué par un autre diagnostic de l'ICHD-3

Question 15

- Vous décidez l'instauration d'un traitement de fond. Lequel (lesquels) pouvez vous proposer à cette patiente?

A propranolol (Avlocardyl.)

B pizotifène (Sanmigran.)

C flunarizine (Sibélium.)

D oxétorone (Nocertone.)

E gabapentine (Neurontin.)

Question 15

- Vous décidez l'instauration d'un traitement de fond. Lequel (lesquels) pouvez vous proposer à cette patiente?

A propranolol (Avlocardyl.)

B pizotifène (Sanmigran.)

C flunarizine (Sibélium.)

D oxétorone (Nocertone.)

E gabapentine (Neurontin.)

CAS CLINIQUE 02

Monsieur H., 25 ans, consulte pour des douleurs de la face. Il a présenté au printemps dernier des douleurs de l'hémiface droite, évoluant par crises, avec des larmes de l'œil droit et une sensation de nez bouché du même côté. Les crises peuvent être multiples dans la journée. Il fume 1 paquet par jour.

C'est actuellement l'automne et les crises reprennent de plus belle.

Il a même été hospitalisé en psychiatrie 3 jours en avril dernier pour tentative de suicide car il ne supportait plus les douleurs. Il est sorti sans diagnostic.

Il n'a aucun antécédent médicochirurgical.

L'examen neurologique en dehors des crises est normal.

Question 1

• Quel est votre diagnostic le plus probable?

A névralgie du trijumeau

B céphalée toxique

C migraine sans aura

D algie vasculaire de la face

E céphalée de tension

Question 1

• Quel est votre diagnostic le plus probable?

A névralgie du trijumeau

B céphalée toxique

C migraine sans aura

D **algie vasculaire de la face**

E céphalée de tension

Question 2

- Quel(s) autre(s) signe(s) pourrait-on rechercher à l'interrogatoire en faveur d'une algie vasculaire de la face?

A la durée de chaque crise entre 15 et 180 min **B** l'existence d'une zone gâchette

C l'amélioration de la crise par le repos et l'obscurité

D une mydriase réactive du côté de la douleur

E une hypersudation au niveau du front

Question 2

- Quel(s) autre(s) signe(s) pourrait-on rechercher à l'interrogatoire en faveur d'une algie vasculaire de la face?

A la durée de chaque crise entre 15 et 180 min

B l'existence d'une zone gâchette

C l'amélioration de la crise par le repos et l'obscurité

D une mydriase réactive du côté de la douleur

E une hypersudation au niveau du front

- **Critères diagnostiques de l'algie vasculaire de la face (code IHS 3.1) selon l'ICHD-3**

A. Au moins 5 crises réunissant les critères B à D;

B. Douleur **unilatérale sévère à très sévère, orbitaire, supraorbitaire et/ou temporale durant 15 à 180 minutes** sans traitement.

C. La céphalée est associée à **au moins un** des signes suivant :

1. Au moins un des signes ou symptômes suivants survenant du côté de la douleur :

- (a) Injection conjonctivale et/ou larmoiement.
- (b) Congestion nasale et/ou rhinorrhée.
- (c) œdème palpébral.
- (d) Sudation du front et de la face.
- (e) Myosis et/ou ptosis.

2. Sensation d'impatience ou agitation motrice.

D. La fréquence des crises varie **d'une crise par jour à 8 crises** par jour.

E. Ne correspondant pas mieux à un autre diagnostic de fréquence

Question 3

- Quel(s) examen(s) paraclinique(s) prescrivez-vous pour confirmer votre hypothèse?

A TDM cérébrale sans injection

B IRM cérébrale avec ARM

C fond d'œil

D ponction lombaire

E aucun

Question 3

- Quel(s) examen(s) paraclinique(s) prescrivez-vous pour confirmer votre hypothèse?

A TDM cérébrale sans injection

B IRM cérébrale avec ARM

C fond d'œil

D ponction lombaire

E aucun

Question 4

- Vous confirmez l'hypothèse de l'algie vasculaire de la face. Quelle(s) est (sont) la (les) modalité(s) de prise en charge que vous proposez?
- **A** éducation et information du patient et de l'entourage
- **B** traitement antidépresseur type inhibiteur de la recapture de la sérotonine
- **C** traitement de crise par oxygénothérapie hyperbare avec masque nasobuccal
- **D** traitement de crise par injection de sumatriptan (Imiject.), maximum deux injections par jour
- **E** aide pour un sevrage tabagique

Question 4

- Vous confirmez l'hypothèse de l'algie vasculaire de la face. Quelle(s) est (sont) la (les) modalité(s) de prise en charge que vous proposez?
- **A éducation et information du patient et de l'entourage**
- **B traitement antidépresseur type inhibiteur de la recapture de la sérotonine**
- **C traitement de crise par oxygénothérapie hyperbare avec masque nasobuccal**
- **D traitement de crise par injection de sumatriptan (Imiject), maximum deux injections par jour**
- **E aide pour un sevrage tabagique**

Question 5

- Satisfait de la prise en charge, il vous adresse en consultation sa cousine âgée de 25 ans qui présente depuis 5 ans des céphalées invalidantes, généralement unilatérales, précédées de symptômes visuels qu'elle décrit comme «bizarres». Lors de ces accès, elle s'isole dans le noir et c'est le seul moyen pour elle de soulager ces céphalées. Le paracétamol est inefficace et elle consulte le moins possible son médecin à cause de ressources très faibles. Elle ne fume pas.
 - Quel(s) critère(s) devez-vous rassembler en faveur d'une migraine avec aura visuelle typique?
- A** au moins cinq crises ayant des caractéristiques similaires
 - B** symptômes visuels positifs ou négatifs unilatéraux
 - C** symptômes visuels débutant dans les 60 minutes après la crise de migraine
 - D** symptômes visuels durant au maximum 60 minutes et totalement résolutifs
 - E** symptômes visuels ipsilatéraux à la crise de migraine

Question 5

- Satisfait de la prise en charge, il vous adresse en consultation sa cousine âgée de 25 ans qui présente depuis 5 ans des céphalées invalidantes, généralement unilatérales, précédées de symptômes visuels qu'elle décrit comme «bizarres». Lors de ces accès, elle s'isole dans le noir et c'est le seul moyen pour elle de soulager ces céphalées. Le paracétamol est inefficace et elle consulte le moins possible son médecin à cause de ressources très faibles. Elle ne fume pas.
 - Quel(s) critère(s) devez-vous rassembler en faveur d'une migraine avec aura visuelle typique?
- A** au moins cinq crises ayant des caractéristiques similaires
- B symptômes visuels positifs ou négatifs unilatéraux**
- C** symptômes visuels débutant dans les 60 minutes après la crise de migraine
- D symptômes visuels durant au maximum 60 minutes et totalement résolutifs**
- E** symptômes visuels ipsilatéraux à la crise de migraine

Critères de migraine avec aura (3rd édition of The international classification of headache disorders [ICHD-3])

A. Au moins deux crises répondant aux critères B et C

B. Au moins un symptôme entièrement réversible d'aura :

1. visuel
2. sensitif
3. parole et/ou langage
4. moteur
5. tronc cérébral
6. rétinien

C. Au moins trois des six caractéristiques suivantes :

1. au moins un symptôme d'aura se développe progressivement sur ≥ 5 minutes
2. deux ou plusieurs symptômes d'aura surviennent successivement
3. chaque symptôme d'aura dure 5-60 minutes
4. au moins un symptôme d'aura est unilatéral
5. au moins un symptôme d'aura est positif
6. l'aura est accompagnée, ou suivie dans les 60 minutes, d'une céphalée

D. N'est pas mieux expliquée par un autre diagnostic de l'ICHD-3

- Vous voyez en consultation une jeune femme de 23 ans. Cette patiente est droitnière, ambulancière, elle vit en concubinage et n'a pas d'enfant. Elle pratique la course à pied et l'escalade.
- Elle a pour antécédents des crises convulsives fébriles compliquées dans la petite enfance.
- Elle prend pour seul traitement une contraception œstroprogestative.
- Cette patiente se plaint d'épisodes stéréotypés se manifestant par une sensation épigastrique ascendante puis une suspension du contact, un mâchonnement décrit par sa mère, présente à la consultation. En post-événementiel, la mère décrit un trouble phasique assez marqué.

